Informe inicial: Brote de Enfermedad Transmitida Por Alimentos en la localidad de Chachapoyas del distrito Chachapoyas de la provincia Chachapoyas departamento de Amazonas, 2026

1. Antecedentes

El día 30/10/2026, en el departamento de Amazonas, provincia Chachapoyas, distrito Chachapoyas, localidad Chachapoyas, jurisdicción del establecimiento de salud HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA, fue notificado un brote relacionado a enfermedad transmitida por alimentos. En esta zona no se tiene antecedentes de brotes similares.

Así también Se reporta la atención de pacientes en el servicio de Emergencia del Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas, quienes presentan síntomas como diarrea, náuseas, dolor abdominal, fiebre, cefalea y malestar corporal, con antecedente común de consumo de alimentos en el comedor de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM). Ante la sospecha de un posible brote de enfermedad transmitida por alimentos (ETA), se viene realizando la investigación epidemiológica en coordinación con la Red de Salud Chachapoyas y la DIRESA Amazonas, a fin de identificar los casos, determinar la posible fuente de exposición e implementar las medidas de prevención y control correspondientes..

2. Situación actual

Hasta el momento, se han reportado 152 casos, 51 hospitalizados y 0 fallecidos para enfermedad transmitida por alimentos.

Del total de casos, 82 corresponden al sexo masculino y 70 al sexo femenino. Asimismo, se reportan 0 niños, 7 adolescentes, 142 jóvenes, 3 adultos y 0 adultos mayores.

La fecha de inicio de síntomas del caso índice fue el 29/10/2026, los síntomas estuvieron caracterizados por cefalea, fiebre, dolor abdominal, diarreas, náuseas, vómitos, mialgias, escalofríos, malestar general, mareos.

Se reportó que el número de expuestos fue 1296, con una tasa de ataque de 11.73 %. Así mismo, el lugar de ocurrencia del evento fue otros / COMEDOR UNIVERSITARIO.

En relación a los alimentos, se identificó como alimentos consumidos a YOGURT, ARROZ A LA JARDINERA CON POLLO, MACA, PAN, ALMENDRAS, SOPA DE TRIGO CON PAPA AMARILLA, ENSAL y alimento sospechoso a TALLARIN VERDE, HUEVO SANCOCHADO con hora de ingesta de 19:00.; el periodo de incubación fue 10 horas.

Se ha realizado toma de muestra con fecha 29/10/2026. El tipo de muestra fue: muestra de alimentos (microbiológicos), cultivo en pacientes, ELISA IgM en pacientes.

Actualmente, la condición de los casos, reporta 51 hospitalizados, 101 ambulatorios y 0 fallecidos.

Tabla 1. Lista de signos y síntomas

N°	Signo / síntoma	Casos	Porcentaje (%)

1	Cefalea	136	89.5%
2	Fiebre	136	89.5%
3	Dolor abdominal	134	88.2%
4	Diarreas	133	87.5%
5	Náuseas	118	77.6%
6	Vómitos	57	37.5%
7	Mialgias	41	27%
8	Escalofríos	28	18.4%
9	Malestar general	22	14.5%
10	Mareos	13	8.6%
	TOTAL	**152**	**100%**

3. Análisis de situación

Evento que afecta a comensales del servicio alimentario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), ubicado en el distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, región Amazonas, servicio concesionado al Consorcio Almaxa (RUC 20615631834), que atiende a 1 296 comensales inscritos en tres turnos diarios (desayuno, almuerzo y cena). Con fecha 29/10/2026 se identificó un incremento de atenciones por cuadro gastrointestinal agudo con compromiso sistémico en estudiantes de la universidad, quienes refieren como antecedente común el consumo de alimentos en dicho servicio.

Según el informe de intervención sanitaria de Salud Ambiental de la Red Integrada de Salud Chachapoyas (RISCH), el primer caso conocido inició síntomas el día 29/10/2026 a las 04:00 horas aproximadamente. El conocimiento del evento se dio mediante reportes del personal del Hospital Regional Virgen de Fátima (HRVF), iniciándose la investigación epidemiológica en coordinación con la Red Integrada de Salud Chachapoyas y la DIRESA Amazonas.

A la fecha se han consolidado 152 casos con Ficha clínico epidemiológica de investigación de casos de ETA (Anexo 1 de la R.M. N.° 683-2014/MINSA), atendidos en el Hospital Regional Virgen de Fátima (75 casos), en el Tópico de Emergencia de la UNTRM (69 casos) y en el Puesto de Salud Higos Urco (12 casos); 4 pacientes fueron atendidos en más de un establecimiento. Asimismo, se tiene información de casos adicionales que se encuentran en evaluación en otros establecimientos de salud, incluidos los servicios de atención de la propia universidad, los cuales serán incorporados conforme se complete su investigación.

Del total de casos, 82 (53,9 %) son de sexo masculino y 70 (46,1 %) de sexo femenino, con una edad mediana de 20 años (rango de 17 a 36 años). Según curso de vida, 142 casos (93,4 %) corresponden a jóvenes, 7 casos (4,6 %) a adolescentes y 3 casos (2,0 %) a adultos. La población afectada está constituida principalmente por estudiantes universitarios de las diez facultades de la universidad; además, 3 casos son estudiantes del CEPRE y 2 casos corresponden a trabajadores del servicio alimentario.

Los pacientes refieren cuadro de inicio agudo caracterizado por fiebre, cefalea, dolor abdominal y deposiciones líquidas, acompañado de náuseas y, en menor proporción, vómitos. Como síntomas adicionales refieren mialgias o dolor corporal, escalofríos, malestar general y mareos. El predominio de fiebre, cefalea y diarrea, con menor frecuencia de vómitos, orienta a un agente bacteriano enteroinvasivo antes que a una intoxicación por toxinas preformadas.

Signos y síntomas referidos:

Cefalea: 136 casos (89,5 %)

Fiebre: 136 casos (89,5 %)

Dolor abdominal: 134 casos (88,2 %)

Diarrea: 133 casos (87,5 %)

Náuseas: 118 casos (77,6 %)

Vómitos: 57 casos (37,5 %)

Mialgia o dolor corporal: 41 casos (27,0 %)

Escalofríos: 28 casos (18,4 %)

Malestar general: 22 casos (14,5 %)

Mareos: 13 casos (8,6 %)

Del total de casos, 51 pacientes (33,6 %) requirieron hospitalización, la mayoría en el Hospital Regional Virgen de Fátima; 74 pacientes recibieron antibioticoterapia, principalmente ciprofloxacino, y 43 pacientes hidratación endovenosa con cloruro de sodio. A la fecha no se registran defunciones.

Respecto a la distribución en el tiempo, la mayor concentración de inicios de síntomas se registró el 29/10/2026 (117 casos; 77,0 %), con el pico entre las 09:00 y las 12:00 horas (35 casos), y un descenso progresivo hasta el 30/10/2026, siendo el último inicio registrado el 30/10/2026 a las 18:00 horas. La curva epidémica presenta un ascenso brusco, un pico único y un descenso gradual, patrón compatible con un brote de fuente común puntual. Se cuenta además con 22 fichas que consignan inicio de síntomas el 28/10/2026, las cuales se encuentran en proceso de verificación.

Considerando el primer caso conocido (29/10/2026, 04:00 horas), el último caso registrado (30/10/2026, 18:00 horas) y el periodo de incubación de Salmonella spp. (6 a 72 horas), agente compatible con el cuadro clínico, el periodo probable de exposición se ubica entre las 18:00 horas del 27/10/2026 y las 22:00 horas del 28/10/2026, comprendiendo la cena del 27/10/2026 y el desayuno, almuerzo y cena del 28/10/2026. Los agentes de periodo de incubación corto (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens) no son compatibles con la duración del brote.

Durante la investigación epidemiológica, el cruce de los casos con el registro de asistencia del servicio alimentario permitió identificar a 140 casos entre los 1 296 comensales inscritos, con una tasa de ataque de 10,8 %. Más del 80 % de los comensales asistió a cada una de las comidas del 28 y 29/10/2026. El almuerzo del 28/10/2026 (sopa de trigo, ensalada, adobo de cerdo, yuca, arroz, manzana y cebada) presentó una tasa de ataque de 11,1 % en quienes asistieron frente a 2,1 % en quienes no asistieron (RR 5,35; IC 95 %: 0,76 a 37,42), sin alcanzar significancia estadística por el reducido número de no expuestos. El desayuno del 29/10/2026 no es compatible como fuente común, debido a que 52 casos iniciaron síntomas antes de dicha comida. En las fichas con detalle de alimentos, los platos más referidos fueron el tallarín verde y el huevo sancochado de la cena del 28/10/2026 y el adobo de cerdo del almuerzo del 28/10/2026; asimismo, 52 fichas consignan consumo en el servicio el 27/10/2026, fecha para la cual no se cuenta con registro de asistencia.

El día 30/10/2026, a las 09:50 horas, el área de Salud Ambiental de la RISCH, con participación de la DIRESA Amazonas, realizó la inspección sanitaria del servicio alimentario, aplicando los Anexos 2 y 3 de la Guía Técnica para la Investigación y Control de Brotes de ETA y la ficha de servicios de alimentación colectiva, obteniéndose un puntaje de 50,7 % (categoría "En proceso"). Se evidenciaron deficiencias de infraestructura e higiene (presencia de moho, insectos, grifos con fugas, pisos y mesas de trabajo deteriorados), registro de proceso incompleto sin control de temperaturas de mantenimiento, e intervalos de aproximadamente 2 h 40 min y 2 h 25 min entre la cocción y el inicio del servido en la cena del 28/10/2026 y el almuerzo del 29/10/2026, respectivamente. Los registros internos de control de agua muestran lecturas frecuentes de cloro residual menores a 0,5 ppm en el primer turno; durante la inspección, el cloro residual libre fue de 0,71 mg/L.

Del total de 38 manipuladores del servicio, se evaluaron 6, de los cuales uno (chef) refirió deposiciones líquidas la madrugada del 30/10/2026. El Laboratorio Referencial de Salud Pública de la DIRESA Amazonas realizó la toma de muestras de heces para coprocultivo e identificación bacteriana a 6 manipuladores y a pacientes atendidos en el Tópico de la UNTRM. Respecto a muestras de alimentos, solo se conservó una muestra de pollo al pimiento correspondiente al desayuno del 29/10/2026, en congelación; no se retuvieron muestras de las demás comidas, quedando su procesamiento a cargo de la universidad.

Se dispuso la suspensión temporal del servicio alimentario hasta el levantamiento de las observaciones sanitarias, la conservación de la muestra de alimento disponible y la coordinación con el Laboratorio Referencial de Salud Pública para el procesamiento de las muestras clínicas. Se continúa con la búsqueda activa de casos en los establecimientos de salud, la verificación de la información consignada en las fichas y el seguimiento de los pacientes.

El evento queda catalogado como brote de enfermedad transmitida por alimentos de fuente común puntual asociado al servicio alimentario de la UNTRM, en investigación epidemiológica, con agente etiológico probable de tipo bacteriano, permaneciendo pendiente el resultado de los coprocultivos y del análisis de alimentos, la obtención del registro de asistencia del 27/10/2026 y la vigilancia de casos nuevos hasta completar dos periodos máximos de incubación sin nuevos casos.

4. Acciones realizadas

Entre las actividades realizadas se encuentran: entrevista a los casos, visita al lugar de ocurrencia, capacitación de manipuladores, implementación de medidas de control en lugar de ocurrencia.

5. Plan de trabajo

FINALIDAD:

Establecer las actividades de investigación epidemiológica, vigilancia, prevención y control del brote de Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) que afecta a los comensales del servicio alimentario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), con la finalidad de identificar la fuente de infección, determinar el probable agente etiológico, caracterizar el evento e implementar medidas de control para evitar la ocurrencia de nuevos casos.

OBJETIVO:

Desarrollar acciones de investigación epidemiológica y control del brote de Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) asociado al servicio alimentario de la UNTRM, mediante la identificación, notificación y seguimiento de casos, el análisis epidemiológico de la información, la investigación de la fuente de exposición y la coordinación interinstitucional para la implementación de medidas de prevención y control.

ACTIVIDADES A DESARROLLLAR:

RED INTEGRADA DE SALUD CHACHAPOYAS – UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA:

• Recepción, análisis y monitoreo de la información epidemiológica remitida mediante notificación inmediata del brote de ETA por los establecimientos de salud.

• Consolidación, depuración y sistematización de las fichas clínico epidemiológicas de investigación de casos de ETA (Anexo 1, R.M. N.° 683-2014/MINSA) en una base única, con verificación de duplicados y de la información consignada.

• Establecimiento y difusión de la definición operacional de caso a todos los establecimientos que atienden casos.

• Coordinación permanente con el Hospital Regional Virgen de Fátima, el Puesto de Salud Higos Urco, EsSalud y el Tópico de Emergencia de la UNTRM para la notificación y el registro de casos.

• Supervisión y monitoreo de la búsqueda activa institucional de casos en los establecimientos de salud y en la universidad, incluidos los casos en evaluación aún no consolidados.

• Caracterización del brote según tiempo, lugar y persona, elaboración de la curva epidémica y estimación del periodo probable de exposición.

• Cálculo de tasas de ataque global, por comida y por facultad, utilizando el registro de asistencia del servicio alimentario como población expuesta.

• Gestión ante la universidad y el Consorcio Almaxa del registro de asistencia del 27/10/2026 y de las horas reales de servicio de cada comida.

• Diseño y aplicación de una encuesta de consumo de alimentos por plato a una muestra de comensales enfermos y no enfermos, para el cálculo de tasas de ataque y riesgo relativo por alimento.

• Seguimiento del procesamiento y de los resultados laboratoriales de coprocultivos de casos y manipuladores, y del análisis de la muestra de alimento conservada.

• Elaboración y remisión de informes de situación y del informe final del brote a la DIRESA Amazonas.

• Monitoreo epidemiológico continuo hasta completar dos periodos máximos de incubación sin aparición de casos nuevos para el cierre del brote.

RED INTEGRADA DE SALUD CHACHAPOYAS – ÁREA DE SALUD AMBIENTAL:

• Vigilancia y control sanitario del servicio alimentario de la UNTRM, con verificación del cumplimiento de la suspensión temporal dispuesta en el acta de inspección.

• Reinspección del servicio alimentario con la ficha de servicios de alimentación colectiva para verificar el levantamiento de observaciones (infraestructura, higiene, flujo de preparación y control de temperaturas).

• Seguimiento al procesamiento de la muestra de pollo al pimiento en laboratorio acreditado, a cargo de la universidad, con parámetros microbiológicos pertinentes (Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, coliformes y Escherichia coli).

• Toma de muestra de agua en el comedor (cloro residual y coliformes) y verificación de la limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento.

• Verificación del control diario de cloro residual (POES N.° 004) y de los registros de temperatura de cocción, mantenimiento y enfriamiento de alimentos.

• Evaluación de la totalidad de manipuladores del servicio (Anexo 3), en coordinación con Epidemiología y el Laboratorio Referencial.

• Vigilancia sanitaria semanal del servicio alimentario tras su reapertura.

HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁTIMA:

• Notificación inmediata de los casos atendidos a la Unidad de Epidemiología de la Red de Salud Chachapoyas según normativa vigente.

• Llenado completo de la ficha clínico epidemiológica de investigación de casos de ETA de todos los pacientes atendidos y remisión de las fichas pendientes.

• Atención, manejo clínico y seguimiento de los pacientes hospitalizados y ambulatorios, con vigilancia de signos de alarma o complicaciones.

• Toma, conservación y envío de muestras de heces para coprocultivo al Laboratorio Referencial de Salud Pública según normativa vigente.

• Reporte diario de pacientes hospitalizados, altas y casos nuevos atendidos.

PUESTO DE SALUD HIGOS URCO:

• Notificación inmediata de los casos atendidos a la Red de Salud Chachapoyas.

• Llenado completo de la ficha clínico epidemiológica de investigación de casos de ETA y verificación de la información consignada (hora de inicio de síntomas y alimentos consumidos).

• Seguimiento clínico de los casos atendidos y referencia oportuna de aquellos que presenten signos de alarma.

• Apoyo en la búsqueda activa de casos en la comunidad universitaria residente en su jurisdicción y en la toma de muestras.

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA – TÓPICO DE EMERGENCIA Y BIENESTAR UNIVERSITARIO:

• Notificación inmediata de casos nuevos atendidos en el tópico y remisión de las fichas clínico epidemiológicas a la Red de Salud Chachapoyas.

• Remisión del registro de asistencia del servicio alimentario del 27/10/2026, del programa de menús y de las horas de servicio de cada comida.

• Apoyo en la búsqueda activa de casos y en la aplicación de la encuesta de consumo de alimentos a estudiantes comensales.

• Procesamiento de la muestra de alimento conservada en laboratorio acreditado, conforme al acta de acuerdos, y entrega de resultados a la DIRESA Amazonas.

• Coordinación con el Consorcio Almaxa para el levantamiento de las observaciones sanitarias antes de la reapertura del servicio.

• Difusión de mensajes preventivos a la comunidad universitaria sobre signos de alarma, consulta oportuna, no automedicación y lavado de manos.

LABORATORIO REFERENCIAL DE SALUD PÚBLICA – DIRESA AMAZONAS:

• Recepción y procesamiento de las muestras de heces de casos y manipuladores para coprocultivo e identificación bacteriana.

• Remisión de los resultados a la Unidad de Epidemiología y coordinación con el Instituto Nacional de Salud para la confirmación y tipificación de aislamientos.

RECURSOS NECESARIOS:

RECURSOS HUMANOS:

• Equipo de Epidemiología de la DIRESA Amazonas.

• Equipo de Epidemiología de la RIS Chachapoyas.

• Personal de Salud Ambiental.

• Personal del Laboratorio Referencial de Salud Pública.

• Personal asistencial de los establecimientos de salud involucrados.

• Autoridades y responsables del servicio alimentario de la UNTRM.

RECURSOS MATERIALES:

• Fichas clínico-epidemiológicas de investigación de ETA.

• Formatos de consolidación y seguimiento de casos.

• Equipos de cómputo y acceso a internet.

• Materiales para la toma y conservación de muestras.

• Insumos y materiales para las actividades de vigilancia sanitaria.

RECURSOS LOGÍSTICOS:

• Movilidad para desplazamiento del equipo de intervención.

• Ambientes para reuniones de coordinación.

• Facilidades para el acceso a la documentación y registros del servicio alimentario.

RESULTADOS ESPERADOS:

• Base de datos de casos de ETA actualizada, depurada y validada.

• Casos sospechosos identificados, investigados y notificados oportunamente.

• Caracterización epidemiológica del brote actualizada, con identificación del periodo probable de exposición y alimentos posiblemente implicados.

• Resultados de laboratorio incorporados a la investigación para contribuir a la identificación del agente etiológico.

• Registro de asistencia del servicio alimentario del 27/10/2026 incorporado al análisis epidemiológico.

• Observaciones sanitarias del servicio alimentario verificadas y levantadas por la autoridad competente.

• Medidas de prevención y control implementadas para evitar nuevos casos.

• Informe final de investigación epidemiológica elaborado y documentado.

INFORME ELABORADO POR:

Yhojar A. Pisfil-Farroñay

Pasante FETP Intermedio.

6. ANEXOS

Responsable del informe:

Roswith Servan Trigoso

rservantrigoso@gmail.com

958513895